

- 59★★★  
☑☑☑ 緑内障を合併する場合、全例で LAMA は禁忌である。
- 60★★★  
☑☑☑ 前立腺肥大症合併例では、全例で LAMA は禁忌である。
- 61★★★  
☑☑☑ 心不全合併例に対して長時間作用性  $\beta_2$  刺激薬 (long-acting  $\beta_2$ -agonist: LABA) は禁忌である。
- 62★★★  
☑☑☑ テオフィリン製剤による気管支拡張作用を得るためには、血中濃度を 30~40  $\mu\text{g/mL}$  にするよう調整する。
- 63★★★  
☑☑☑ テオフィリンには胃酸分泌亢進作用がある。
- 64★★★  
☑☑☑ 軽症例ではテオフィリン単剤での管理も可能である。
- 65★★★  
☑☑☑ 軽症例では吸入ステロイド (inhaled corticosteroid: ICS) 単剤での治療も可能である。
- 66★★★  
☑☑☑ 抗酸菌感染症合併例に対する ICS の投与は望ましくない。
- 67★★★  
☑☑☑ 明らかな喘息合併例でなくても、末梢血好酸球数が 100 /  $\mu\text{L}$  以上であれば、LAMA や LABA に ICS の上乗せを検討してよい。
- 68★★★  
☑☑☑ 肺炎を反復する症例では、LAMA や LABA に加えて積極的に ICS の上乗せを検討する。
- 69★★★  
☑☑☑ 吸入する力が弱い症例ではドライパウダー製剤を用いる。
- 70★★★  
☑☑☑ LAMA や LABA の吸入後にはうがいが必要である。
- 71★★★  
☑☑☑ マクロライド系抗菌薬の少量長期投与療法により、急性増悪の抑制や QOL の向上が示されている。
- 72★★★  
☑☑☑ 在宅酸素療法 (HOT) 導入例の基礎疾患として最多である。